

1. Dénomination du médicament
ZENAVAN Gel.

2. Composition qualitative et quantitative
Etofénamate, 50 mg par gramme de gel.
Excipients, voir 6.1.

3. Forme pharmaceutique
Gel.

4. Données cliniques

4.1. Indications thérapeutiques

ZENAVAN Gel est indiqué dans les situations douloureuses associées à l'appareil locomoteur, quand la symptomatologie est confinée à des surfaces limitées, telles que:

- Arthropathies (périarthrite, arthrite, arthrose, polyarthrite, spondylose, ostéoarthrose);
- Myalgies
- Bursites.
- Téo-synovites
- Fibrosites
- Névralgies (syndrome cervical, lombalgies, sciatalgies)
- Contusions, entorses, distensions (associées, par exemple, à des traumatismes sportifs).

4.2. Posologie et mode d'administration:

Sauf indication médicale en contraire on utilisera ZENAVAN comme suit:

Appliquer 5 à 10 cm d'un cylindre de gel (correspondant environ 1,7-3,3 g de gel), selon la surface douloureuse.

On fera l'application 3 à 4 fois par jour en massant l'endroit affecté.

En cas de maladies rhumatismales, le traitement pendant 3- 4 semaines est généralement suffisant dans la plupart des cas. La durée du traitement dans les traumatismes aigus (par exemple, associés à la pratique sportive) peut se prolonger jusqu'à 2 semaines.

4.3 Contre-indications

On ne doit pas appliquer ZENAVAN Gel dans les situations suivantes :

- Hypersensibilité à l'etofénamate, à l'acide flufenamique ou à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens,
- sur une peau avec des lésions eczémateuses ou plaies ouvertes.
- Grossesse
- Enfants et insuffisance rénale, car il n'existe pas de l'expérience clinique suffisante

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur les yeux.

Ne pas exposer au soleil la région traitée pendant le traitement et après les deux semaines suivantes.

4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction

On n'a pas rapporté d'interactions médicamenteuses ou autres quand on utilise ZENAVAN selon la posologie recommandée.

4.6. Grossesse et allaitement

L'etofénamate ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Les femmes allaitantes ne doivent utiliser l'etofénamate que pendant de courtes périodes de temps et sur des petites surfaces.

4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Il n'affecte pas ces activités.

4.8. Effets indésirables

Rarement, il peut survenir des rougeurs sur la peau. Très rarement, des réactions cutanées allergiques (démangeaison, peau rouge, éruption, oedème) peuvent apparaître.

4.9. Surdosage

Ce n'est pas probable si on respecte les doses et les recommandations mentionnées dans cette littérature.

Si tout le contenu d'un tube ou d'un flacon fut appliqué sur la surface corporelle dans une courte période de temps, il peut survenir des maux de tête, des vertiges et/ou douleurs abdominales. Les mesures recommandées comprennent le rinçage abondant à l'eau de toute la substance non absorbée.

Généralement, on n'atteint pas de doses toxiques par voie orale. En cas échéant, on doit procéder à un lavage gastrique, au vomissement et à l'administration de charbon activé.

Dans de telles situations on doit se diriger immédiatement à l'Unité de Santé la plus proche.

5. Propriétés pharmacologiques

5.1. Propriétés pharmacodynamiques

Code ATC: M02A A06.

L'etofénamate est un anti-inflammatoire non stéroïdien ayant des propriétés analgésiques. Son effet antiflogistique élevé, documenté dans des expériences chez l'animal et confirmé dans des plusieurs études chez l'Homme, est dû à des différentes actions individuelles. L'etofénamate agit sur plusieurs phases du processus inflammatoire : inhibition de la synthèse des prostaglandines, inhibition de la libération de l'histamine, effet antagoniste de la bradykinine et de la sérotonine, inhibition de l'activité du complément et inhibition de la libération de l'hyaluronidase.

L'etofénamate a des propriétés stabilisatrices des membranes, prévenant la libération des enzymes protéolytiques. Ce fait détermine l'inhibition de la réponse inflammatoire exsudative et proliférative et la diminution des réactions anaphylactiques et de réponse aux corps étrangers.

5.2. Propriétés pharmacocinétiques

Concentration plasmatique: Après l'application topique de 300 mg d'etofénamate dans des volontaires sains, la concentration sanguine maximale de fénamates a été observée 12 à 24 heures après l'administration.

Liaison aux protéines plasmatiques: de 98 à 99%.

Métabolisme et élimination: L'etofénamate est excrété sous la forme de différents métabolites et leur conjugués : 35% par voie rénale et un grand pourcentage par voie biliaire et fécale. Probablement il y a de la circulation entéropathique.

Biodisponibilité : La biodisponibilité des produits contenant de l'etofénamate subit des oscillations inter et intra-individuelles, dépendant de l'endroit d'administration, des caractéristiques de la peau et d'autres facteurs. Après l'application topique cutanée, la biodisponibilité relative est d'environ 20%.

6. Données pharmaceutiques

6.1. Liste des excipients

Alcool isopropylique, Carbopol 940, Eumulgin M8, Hydroxyde de sodium, Macrogol 400, Eau purifiée.

6.2. Incompatibilités

On ne connaît pas.

6.3. Durée de conservation

5 ans.

6.4. Précautions particulières de conservation

Conserver à température non supérieure à 25°C.

6.5. Nature et contenance du récipient

Tube d'aluminium contenant du gel, dans une boîte de carton. Chaque boîte contient 1 tube et une littérature médicale.

6.6. Instructions d'utilisation et mode d'application

Après appliquer le gel il faut masser doucement la surface d'application.

7. Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché

BIAL –Portela & C^a.S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

PORTUGAL